



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : صباح احمد محمد صالح
المحافظة : الجيزة
الحى / المدينة : بولاق الدكرور
العنوان : ش-شحاته الجمل
رقم البطاقة : 25505010104385 رقم التليفون : 01115093601
العمر (تاريخ الميلاد) : 01-05-1955 المهنة : بدون عمل
تاريخ تسجيل الإستمارة : 23-09-2026

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإخصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----)
المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام تصوير مقطعي للصدر والبطن والحوض بالصبغة
قسم العلاج :
الأورام

[11129]

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني
الاسم : د/ندى حسن
الاسم : د/نرمين رمضان
الوظيفة :
الوظيفة :
الوظيفة :
التوقيع :
التوقيع :
التوقيع :
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د.

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى :
قسم :
جهة العلاج :
نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: صباح احمد محمد صالح National ID: 25505010T04385	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حمید بالثدي و تحتاج الي Contrast-enhanced CT of chest, abdomen and pelvis.

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية



صباح

عبدالقادر بركات حسن

١١ ش ١٠ - منشية جمال عبدالناصر

حلوان - القاهرة



٢٦٨ ١٢ ١٤ ٠١ ٠٣ ٤٤ ٩

JC4657065



٢٠٢١/١٠ ٢٦٨ ١٢ ١٤ ٠١ ٠٣ ٤٤ ٩

ربة منزل



أنثى مسلمة

ابراهيم على محمد النعماني

البطاقة سارية حتى ٢٠٢٨/١٠/٢٦





رسوم الاستعلام 20 جنية

جاءه الاصدار : فرع القاهرة

تاريخ الاصدار : 2026-7-15

الى من يهمه الامر

الهيئة العامة للتأمين الصحي تعمل من خلال قوانين منظمة للانتفاع الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 25 لسنة 1977 "القوى العاملة والمعاشات والارامل " و كذلك قانون 99 لسنة 1992 الخاص بطلاب المدارس و قانون رقم 86 لسنة 2012 " الاطفال دون السن المدرسي " وقانون رقم 23 لسنة 2012 الخاص بالمرأة المعيلة .
وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من التأمينات الاجتماعية
وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من الضمان الاجتماعي .
والبحث تبين أن

السيد (ة) صباح عبد القادر بركات بطاقة رقم 26812140103449
تليفون رقم: لا يوجد

وطبقا الى خطاب من التأمينات الاجتماعية يفيد عدم الانتفاع
يعتبر من الفئات غير المنتفعة بالتأمين الصحي صدر هذا الخطاب دون ادنى مسئولية على الهيئة العامة للتأمين الصحي حال خضوع المواطن لقانون التأمين الصحي الشامل

تاريخ الطباعة : 2026-7-15

الموظف المختص
محمود عبدالله



إفادة مركز تنظيم المعلومات
يعتمد،،

مسلسل 2024400



د / محمد ربيع

الخطاب سارى لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار إلا فى حالة تغيير حاله المواطن من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أو وزارة التضامن الاجتماعى أو وزارة التربية والتعليم

الإدارة المركزية لتنظيم المعلومات و التحول الرقمي

Patient ID: 97278	Patient Name English: Sabah Abdalkader Barakat Hassan
Age: ٥٧ سنة, ٦ شهر	2026/07/15 10:01:48 AM :Report Date

Contrast enhanced Spectral Mammography

CLINICAL SUMMARY: right retro-areolar pathologically proven papillary lesion.

CC & MLO low energy & recombined (post contrast) images

FINDINGS:

Background Uptake: mild background enhancement

ACR: c (heterogenous mammary parenchyma that may obscure small lesions)

RIGHT BREAST:

- **Low energy (Non contrast) images:** show Retro-areolar partially circumscribed partially obscured equal density mass lesion.
- UOQ posterior third focal asymmetry with few overlying amorphous microcalcifications.
- Closely related to such asymmetry two circumscribed fat containing lesions.
- **Recombined (Post contrast) images:** show retro-areolar circumscribed heterogeneously enhancing mass lesion of low conspicuity measuring 15 x 14 x 12 mm.
- UOQ, posterior third, 10 cm from nipple, heterogeneously enhancing mass lesion of high conspicuity measuring 22 x 21 x 21 mm.
- Closely related two heterogeneously enhancing mass lesions (seen 5 mm from the forementioned mass lesion).
- Normal skin / nipple / areolar complex.
- **Complementary US:** retro-areolar intraductal mass lesion, pathologically proven papillary.
- 10 o'clock, posterior third, 6 mm deep to the skin, indistinct anti-parallel hypoechoic suspicious mass lesion.
- 10 o'clock, posterior third, 5 mm from the forementioned mass lesion three intra-mammary indeterminate lymph nodes, the largest two measured 11 x 5 mm and 11 x 7.6 mm with 2mm & 2 mm cortical thickness respectively.
- Non-specific axillary nodes.

LEFT BREAST:

- **Low energy (Non contrast) images** No masses, asymmetry or distortion or suspicious microcalcifications.
- **Recombined (Post contrast) images** show no pathological mass or non-mass enhancement.
- Normal skin / nipple / areolar complex.
- **Complementary ultrasound: benign findings.**

IMPRESSION:

RIGHT BREAST: (BIRADS 4b= moderately suspicious) UOQ posterior third mass enhancement with adjacent indeterminate intra-mammary lymph nodes & retro-areolar pathologically proven papillary enhancing mass lesion.

LEFT BREAST: (BIRADS 2= benign) benign findings.

RECOMMENDATION:

For US guided Tru-cut biopsy of the newly discovered UOQ posterior third suspicious mass lesion & adjacent indeterminate intra-mammary lymph nodes.

Best regards,

Dr. Amal Hegazi, M.Sc.

Dr. Amira Shaheen

Patient Name	صباح احمد محمد	Case No.	342460
Sex/Age	Female 71 Y	Patient No.	24885
Registered Date	16/7/2026 01:58:33 PM	Referred By Dr.	Out Patient
Validation Date	19/9/2026 03:02:50 PM	Branch	Gustave Roussy
Reporting Date	23/9/2026 10:39:17 AM	Pathology No.	2247/26

Clinical Data: Left breast mass (BIRADS 5) diagnosed "Invasive duct carcinoma grade 2"

Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected on 16/07/2026, at 1:58pm. Cold ischemia time is 20 seconds.

Gross Examination:

-Five fragmented grey, white tissue cores, ranging in size between 1.0 cm & 1.2 cm long, totally submitted.

Technique:

- Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Bench Mark ULTRA system for;
 - ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

Microscopic examination:

-**Histologic type:** Invasive duct carcinoma.
 - **Histologic grade:** 2 (differentiation 3, pleomorphism 2, mitosis 1).
 - **DCIS:** Absent.
 - **Microcalcification:** Present.
 - **Angioinvasion:** Absent.
 - **Perineural invasion:** Present.

Results:

* IPT (All controls showed appropriate reactivity):
 - ER: Strong nuclear reaction in 99% of tumor cells (score 8/8).
 - PR: Strong nuclear reaction in 50% of tumor cells (score 7/8).
 - Her2: Faint incomplete membrane reaction in more than 10% of tumor cells (score 1+).
 - Ki67%: 10%.





Gustave Roussy International-Egypt- Pathology Lab
جوستاف رويسى انترناتيونال - مصر - معمل الباثولوجى



Patient Name	صباح احمد محمد	Case No.	342460
Sex/Age	Female 71 Y	Patient No.	24885
Registered Date	16/7/2026 01:58:33 PM	Referred By Dr.	Out Patient
Validation Date	19/9/2026 03:02:50 PM	Branch	Gustave Roussy
Reporting Date	23/9/2026 10:39:17 AM	Pathology No.	2247/26

Conclusion:

Left breast mass, Tru-cut biopsy:

-Invasive duct carcinoma, Grade 2.

IPT:

- ER: Positive (score 8/8).

- PR: Positive (score 7/8).

- Her2: Low (score 1+).

- Ki67%: 10%.

**Scoring system: "ER, PR"

ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66% and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, weak, 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.

** Scoring system: "Her2"

Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendation. IHC 0 (Null): as defined by no staining observed. IHC 0+ (Ultra-low) as defined by membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within > 10% of the invasive tumor cells.

IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within > 10% of the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is complete, intense > 10% of tumor cells.

Signature

Dr. Walaa Ibrahim Ghoneim, MD.



شقة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رئيسى رقم (987) - معمل الباثولوجى - القاهرة 3 - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Al-Khar El Qadima - Cairo, Egypt

HEALTH INSURANCE ORGANIZATION
CENTER DEPARTMENT OF
INFORMATION SYSTEM AND DIGITAL
TRANSFORMATION



الهيئة العامة للتأمين الصحي
الادارة المركزية للنظم المعلومات و التحول
الرقمي

رسوم الاستعلام 20 جنية

جهة الاصدار : فرع الجيزة

تاريخ الاصدار : 2026-7-15

الى من يهمه الامر :.....

الهيئة العامة للتأمين الصحي تعمل من خلال قوانين منظمة للانتفاع الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 25 لسنة 1977 "القوى العاملة والمعاشات والارامل " و كذلك قانون 90 لسنة 1992 الخاص بطلاب المدارس و قانون رقم 86 لسنة 2012 "الاطفال دون السن المدرسي" وقانون رقم 23 لسنة 2012 الخاص بالمرأة المعيلة .

وطبقا لقاعدة البيانات المرسله من التأمينات الاجتماعيه
وطبقا لقاعدة البيانات المرسله من الضمان الاجتماعي

والبحت تبين أن

السيد (ة) صباح احمد محمد صالح بطاقة رقم 25505010104385

تليفون رقم: لا يوجد

وطبقا الى خطاب من التأمينات الاجتماعية يفيد عدم الانتفاع
يعتبر من الفئات غير المنتفعه بالتأمين الصحي صدر هذا الخطاب دون اننى مسئولية على الهيئة العامة للتأمين الصحي حال خضوع المواطن لقانون التأمين الصحي الشامل

وشكرا

تاريخ الطباعه : 2026-7-15

الهيئة العامة للتأمين الصحي

فرع : الجيزة /وقف المختص

إدارة النظم والمعلومات

قسمه المعلومات كريمة ابراهيم

إفادة مركز نظم المعلومات

يعتمد،،،،،

ممسلسل 2023852



الخطاب سدرى لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار الا فى حاله تغيير حاله المواطن من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعيه أو
وزارة التضامن الاجتماعى أو وزارة التربية و التعليم

الادارة المركزية لنظم المعلومات و التحول الرقوى

Patient ID: 140726-133044	Patient Name English: Sabah ahmed
Age	2026/07/14 12:03:26 PM : Report Date

Women's Health Outreach Program

Bilateral Full field Digital Mammography and high-resolution ultrasound.

Clinical summary: left breast lump.

Left breast:

- Heterogeneously dense breast (ACR density c), with scattered partially obscured lobulated dense lesions, mainly at UOQ.
- The Left breast shows lower midline posterior 1/3 irregular ill-defined spiculated dense mass lesion with foci of calcifications within.
- Tubular density noted anterior to the lesion , middle third with suspicions linear microcalcifications within
- Scattered foci of punctate calcifications.
- **Ultrasound** revealed an irregular ill-defined hypoechoic mass lesion, noted at 5 o'clock zone c , measures 24 x 18 mm , seen resting on underlying muscle , and invading overlying skin , with peripheral color uptake on Doppler study. Adjacent anterior prominent ducts seen extending anteriorly to zone b
- Small oval hypoechoic lesion with echogenic center, seen adjacent to index mass, measures 4 x 3 mm ? IMLN
- Scattered clear cysts seen within the parenchyma , largest noted at 1 o'clock measures 11 x 8 mm .
- Retro areolar dilated ducts reach up to 3 mm in diameter.
- Normal nipple/areolar complex.
- Level I one axillary LN , globular measures 4 x 3 mm , with eccentric hilum , cortical thickness 3 mm (indeterminate).

Right breast:

- Heterogeneously dense breast (ACR density c), with scattered partially obscured rounded dense lesions
- Scattered punctate calcifications
- No distortion or suspicious clusters of micro calcifications.
- **Ultrasound** demonstrated scattered anechoic cysts of average size 7 mm.
- Retro areolar dilated clear ducts reach up to 3.5 mm
- Normal skin/subcutaneous tissue and nipple/areolar complex.
- Non-specific axillary LNs.

Impression:

- **Left breast (BIRADS 4c):** 5 o'clock malignant mass lesion as described with suspected ductal extension and ipsilateral indeterminate level I axillary lymph node. Fibrocystic changes .Core needle biopsy and MRI/CESM study is recommended.
- **Right breast (BIRADS 2):** Fibrocystic changes.

Much obliged,
Dr. RANIA AHMED, MD